Centre hospitalier intercommunal du Val-de-Brenne
Service de cardiologie – Unité de soins intensifs cardiologiques
12, avenue des Tilleuls – 37190 Sainte-Aure-sur-Brenne
Secrétariat : 02 47 00 18 52 – cardiologie@chi-valdebrenne.example

Compte rendu d'hospitalisation

Patient	M. Gérard Vasseur	**Né le**	04/09/1958
Entrée	12/02/2027 (urgences)	**Sortie**	16/02/2027
Médecin traitant	Dr Anne Lemaire, Sainte-Aure	**IPP**	0048213

Motif d'hospitalisation

Le patient a été admis pour une douleur thoracique constrictive apparue au repos, évoluant depuis deux heures. L'électrocardiogramme initial montrait un sus-décalage du segment ST dans le territoire inférieur.

Antécédents

- Hypertension artérielle traitée depuis 2015
- Dyslipidémie non traitée
- Tabagisme sevré en 2019 (30 paquets-années)
- Pas d'allergie médicamenteuse connue

Histoire de la maladie et évolution

Une coronarographie réalisée en urgence a mis en évidence une occlusion de l'artère coronaire droite moyenne. Une angioplastie avec pose d'un stent actif a permis une reperméabilisation complète, avec un flux TIMI 3 en fin de procédure. Les suites ont été simples, sans récidive douloureuse ni trouble du rythme sur la surveillance scopique.

Le patient a été mobilisé dès le deuxième jour et a pu déambuler dans le service sans dyspnée.

Examens complémentaires

Biologie

Paramètre	Résultats		Valeurs usuelles
	Entrée 12/02	Sortie 15/02	
Troponine T hs (ng/L)	412	96	< 14
NT-proBNP (pg/mL)	1 860	940	< 300
Créatinine (µmol/L)	88	91	59 – 104
Potassium (mmol/L)	4,1	4,4	3,5 – 5,0
Hémoglobine (g/dL)	13,9	13,2	13,0 – 17,0
LDL-cholestérol (g/L)	1,62	—	< 0,55 (objectif)

Imagerie

L'échocardiographie transthoracique du 14 février retrouve une hypokinésie inférieure avec une fraction d'éjection estimée à 52 %. Il n'existe ni épanchement péricardique ni valvulopathie significative.

Conclusion

Il s'agit d'un infarctus du myocarde inférieur traité par angioplastie primaire, avec une fonction ventriculaire gauche conservée. Le patient regagne son domicile le 16 février 2027 dans de bonnes conditions.

Traitement de sortie

Médicament	Matin	Midi	Soir	Remarques
Acide acétylsalicylique 75 mg	1	–	–	Au long cours
Ticagrélor 90 mg	1	–	1	Pendant 12 mois, jusqu'au 16/02/2028
Bisoprolol 2,5 mg	1	–	–	Adapter selon la fréquence cardiaque
Ramipril 2,5 mg	–	–	1	Contrôle de la kaliémie à J10
Atorvastatine 80 mg	–	–	1	Bilan lipidique à 6 semaines

Recommandations

1. Réadaptation cardiaque en centre spécialisé, à débuter dans les quatre semaines.
2. Consultation de cardiologie à six semaines avec épreuve d'effort.
3. Arrêt de travail jusqu'à la consultation de contrôle.
4. Reconsulter en urgence en cas de douleur thoracique de plus de quinze minutes (appeler le 15).

Un courrier a été adressé au médecin traitant avec l'ensemble des résultats. Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Dr Claire Fontanel
Praticien hospitalier, cardiologie
Sainte-Aure, le 16/02/2027